

TEMA 9.12 • RESPIRATORIO

Neumonía adquirida en la comunidad

PERFIL EUNACOM 1.08.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las **neumonías atípicas** son cuadros infecciosos del parénquima pulmonar causados por microorganismos que no siguen el patrón clínico ni radiológico de la neumonía bacteriana clásica (como la causada por *Streptococcus pneumoniae*). Se caracterizan por una presentación más subaguda, síntomas extrapulmonares y una respuesta nula a los antibióticos que actúan sobre la pared celular.

Etiología: Los "Gérmenes Atípicos"

Existen tres microorganismos principales responsables de estos cuadros:

- **Mycoplasma pneumoniae**: Es el agente más frecuente de neumonía atípica, especialmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes.
- **Chlamydia pneumoniae**: Causa frecuente de brotes en comunidades cerradas.
- **Legionella pneumophila**: Suele presentarse en pacientes de mayor edad o con factores de riesgo (aire acondicionado, tabaquismo), pudiendo ser más grave.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología y Resistencia: Los gérmenes atípicos, especialmente el *Mycoplasma*, carecen de una pared celular de peptidoglicano rígida o son intracelulares obligados. Por esta razón, los **betalactámicos** (penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos) no tienen ningún efecto sobre ellos, ya que su mecanismo de acción es precisamente inhibir la síntesis de dicha pared.

Cuadro Clínico: La "Clínica Atípica"

A diferencia de la **Neumonía Adquirida en la Comunidad** típica, que es de inicio brusco y febril, la neumonía atípica es un **cuadro arrastrado**.

- **Temporalidad:** El paciente suele consultar tras **7 a 14 días** (e incluso hasta 20 días) de síntomas.
- **Pródromos:** Comienza de forma indistinguible de una infección viral respiratoria alta (coriza, odinofagia, cefalea).
- **Progresión:** Evoluciona hacia una **tos persistente y seca** (muy característica del *Mycoplasma*). Puede desencadenar crisis de **Asma** en pacientes susceptibles.
- **Disnea:** Aparece de forma tardía y suele ser de esfuerzos.
- **Edad:** Es mucho más común en niños y adultos jóvenes. Es poco frecuente ver neumonías por *Mycoplasma* en mayores de 30-40 años sin factores epidemiológicos claros.

Hallazgos al Examen Físico

Es fundamental notar que **no suele haber un síndrome de condensación** (no hay matidez localizada ni sopro tubario). - **Auscultación:** Presencia de **crépitos bilaterales y difusos**, con predominio en las bases pulmonares. - **Obstrucción:** Es muy frecuente encontrar sibilancias (clínica obstructiva), lo que a menudo confunde el diagnóstico con una bronquitis aguda o crisis asmática.

Manifestaciones Extrapulmonares y Perlas Clínicas

El *Mycoplasma pneumoniae* es conocido por asociarse a fenómenos inmunológicos y sistémicos:

- **Miringitis Bulosa:** Presencia de vesículas o bulas en la membrana timpánica (causa otalgia intensa). También puede verse en infecciones por Adenovirus.
- **Eritema Multiforme Menor:** Lesiones cutáneas en "tiro al blanco".
- **Anemia Hemolítica:** Por aglutininas frías (IgM).
- **Síndrome Hemolítico Urémico (SHU):** Una complicación grave aunque muy infrecuente.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si en el EUNACOM te describen un paciente joven con tos de dos semanas, una radiografía con infiltrado intersticial bilateral y **bulas en el tímpano**, la respuesta siempre es **Mycoplasma pneumoniae**.

Diagnóstico por Imágenes

En la radiografía de tórax, el patrón es muy distinto al foco de condensación lobar típico:

- **Patrón Alveolo-Intersticial:** Infiltrados reticulonodulares finos.
- **Engrosamiento Peribronquial:** Se observa una trama bronquial más marcada.
- **Distribución:** Bilateral y difusa, habitualmente con mayor compromiso en las bases.
- **Disociación Clínico-Radiológica:** A veces la radiografía se ve "peor" de lo que el paciente aparenta clínicamente.

Diagnóstico Diferencial

TABLA 9.12.1: CARACTERÍSTICA VS NEUMONÍA TÍPICA

CARACTERÍSTICA	NEUMONÍA TÍPICA	NEUMONÍA ATÍPICA
Inicio	Brusco (horas/días)	Subagudo (semanas)
Fiebre	Alta con calofríos	Moderada o ausente
Tos	Productiva (expectoración)	Seca, persistente
Examen Físico	Condensación focal	Crépitos difusos / Sibilancias
Radiografía	Condensación lobar	Infiltrado intersticial bilateral
Laboratorio	Leucocitosis marcada	Leucocitos normales o levemente elevados

Tratamiento

Debido a la resistencia intrínseca a los betalactámicos, el tratamiento debe realizarse con antibióticos que actúen a nivel de la síntesis de proteínas o del ADN bacteriano.

- **Macrólidos (Elección):**
 - *Clarithromicina 500 mg cada 12 horas*.
 - Azitromicina 500 mg al día.
- **Quinolonas Respiratorias:**
 - *Levofloxacino o Moxifloxacino (útiles si hay sospecha de resistencia o en adultos mayores)*.
- **Tetraciclinas:**
 - Doxiciclina (alternativa eficaz y de bajo costo).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Error común: Tratar una sospecha de neumonía atípica con Amoxicilina o Cefalosporinas. El paciente no mejorará y el cuadro seguirá progresando. Siempre que el cuadro sea arrastrado y con compromiso intersticial, se debe cubrir con un macrólido.

NOTA CLÍNICA

Si bien el tratamiento de la NAC habitualmente es empírico, si se sospecha específicamente de **Legionella** (paciente más grave, síntomas gastrointestinales, hiponatremia), las quinolonas suelen ser preferidas sobre los macrólidos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 45 años consulta por fiebre, tos productiva y dolor torácico pleurítico de 3 días de evolución. Al examen físico presenta crepitaciones y respiración soplante en base derecha. La radiografía de tórax no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Neumonía adquirida en la comunidad. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El diagnóstico de NAC es fundamentalmente clínico; la radiografía es un examen de apoyo
- El síndrome neumónico incluye: fiebre, tos productiva, respiración soplante, aumento de vibraciones vocales, broncofonía, crepitaciones y matidez
- Si hay clínica de neumonía sin radiografía o con radiografía normal, se inician antibióticos empíricos igualmente
- Con radiografía normal se controla en 2 días (tiempo de consolidación radiológica)
- El CURB-65 evalúa: Conciencia, Uremia, Respiración >30, Blood pressure <90/60 y edad >65
- CURB-65 de 0-1: ambulatorio; 2: sala ERA; 3: sala general; 4-5: UCI
- El CURB-65 no reemplaza el juicio clínico; la clínica siempre manda
- El tratamiento inicial es con antibióticos empíricos sin esperar identificación del agente causal
- Un paciente con insuficiencia respiratoria severa se hospitaliza independiente del puntaje CURB-65

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD)**PREGUNTA 1**

Paciente de 45 años consulta por fiebre, tos productiva y dolor torácico pleurítico de 3 días de evolución. Al examen físico presenta crepitaciones y respiración soplante en base derecha. La radiografía de tórax no muestra alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Solicitar TAC de tórax para confirmar diagnóstico
- B)** Iniciar antibióticos empíricos y controlar con radiografía en 2 días
- C)** Descartar neumonía y buscar otras causas de dolor torácico
- D)** Indicar antiinflamatorios y control ambulatorio en una semana
- E)** Hospitalizar para estudio con hemocultivos y cultivo de expectoración

PREGUNTA 2

¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte del score CURB-65?

- A)** Compromiso de conciencia
- B)** Frecuencia respiratoria mayor a 30
- C)** Saturación de oxígeno menor a 90%
- D)** Presión arterial menor a 90/60 mmHg
- E)** Edad mayor a 65 años

PREGUNTA 3

Paciente de 70 años con NAC presenta CURB-65 de 1 punto (solo por edad), pero al examen físico tiene saturación de 80%, cianosis periférica y uso de musculatura accesoria. ¿Cuál es la conducta correcta?

- A)** Manejo ambulatorio con antibióticos orales según el puntaje CURB-65
- B)** Hospitalización breve en sala ERA
- C)** Hospitalizar, evaluar gases arteriales y manejar insuficiencia respiratoria
- D)** Repetir radiografía en 2 días y reevaluar
- E)** Derivar a urgencias solo si empeora

RESUMEN: NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una de las patologías respiratorias más importantes. Su diagnóstico es clínico-radiológico, siendo la clínica lo fundamental. El síndrome neumónico se presenta con fiebre, malestar general, tos con expectoración mucopurulenta o purulenta, dolor torácico pleurítico (puntada de costado), abolición del murmullo pulmonar con respiración soplante o tubaria, aumento de las vibraciones vocales, broncofonía, crepitaciones localizadas y matidez en la zona de condensación. El diagnóstico es fundamentalmente clínico: si hay clínica de neumonía sin radiografía disponible, se inician antibióticos empíricos. Si la radiografía está normal pero la clínica es sugerente, también se inician antibióticos y se controla con nueva radiografía en dos días, ya que la neumonía puede demorar ese tiempo en consolidar radiológicamente. Solo si persiste normal en el control se suspenden antibióticos y se buscan otras causas. La decisión de manejo ambulatorio versus hospitalizado se basa en el score CURB-65, que evalúa cinco parámetros: compromiso de Conciencia, Uremia (creatinina elevada), frecuencia Respiratoria mayor a 30, Blood pressure menor a 90/60, y edad mayor a 65 años. Con 0-1 puntos el manejo es ambulatorio, con 2 puntos se hospitaliza brevemente en sala ERA, con 3 puntos en sala general y con 4-5 puntos en UCI. Sin embargo, el CURB-65 no reemplaza el juicio clínico: un paciente con insuficiencia respiratoria severa, desaturación o compromiso hemodinámico importante debe hospitalizarse independientemente del puntaje.